

TS

Comunicazione

Comunicare è l'azione del «mettere in comune» tramite:

PAROLE DETTE O SCRITTE

ma anche attraverso...

... IL SILENZIO

TS

COMUNICAZIONE EFFICACE:

- MANTIENI UN CONTATTO VISIVO CON LA PERSONA
- ASCOLTA ATTIVAMENTE ED EMPATIZZA
- CHIEDI INFORMAZIONI ALL'UTENTE/FAMIGLIA
- USA SEMPRE CORTESIA e RISPETTO
- USA UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE
- CHIAMA LA PERSONA CON IL SUO NOME
- NON PERDERE MAI LA CALMA

RICORDA CHE IL TUO CORPO PARLA ANCHE QUANDO LA TUA BOCCA TACE...

TS

COMPORTAMENTI DA EVITARE:

- CREARE ASPETTATIVE IRREALI
- FARSÌ GUIDARE DAI PREGIUDIZI
- VIOLARE LA PRIVACY
- ALZARE IL TONO DELLA VOCE SENZA MOTIVO
- INTERROMPERE IL PAZIENTE
- CERCARE UN'ECESSIVA CONFIDENZA
- PARLARE TROPPO

TS

con il bambino:

**RICORDATI CHE DEVI ASSISTERE DUE PAZIENTI:
il bambino e il genitore/tutore**



**FAVORISCI IL CONTATTO
GENITORE/TUTORE**

**PARLA AL BAMBINO METTENDOTI
ALLA SUA ALTEZZA. NON
PARLARGLI MAI DALL'ALTO IN BASSO**

**USA UN TONO DI VOCE CALMO E
RASSICURANTE**

RISPETTA I SUOI TEMPI

WAREL 118 Emergenza 112

TS

con l'anziano:



**DAI IL TEMPO SUFFICIENTE PER RISPONDERE ALLE
DOMANDE /ELABORARE PENSIERI /ESPRIMERSI**

USA UN TONO DI VOCE CALMO E RASSICURANTE

STAI ATTENTO AI DEFICIT COGNITIVI E FISICI

**PERMETTI DI INDOSSARE GLI AUSILI INDISPENSABILI PER
LE RELAZIONI SOCIALI (occhiali, apparecchio acustico, ecc.)**

CONSIDERA SEMPRE I FAMILIARI O GLI AMICI

RICORDA L'IMPORTANZA DEL CONTATTO FISICO

USA SEMPRE IL DOVUTO RISPETTO

WAREL 118 Emergenza 112

TS

**con il paziente affetto da
disturbo psichico:**



USA UN TONO DI VOCE CALMO E RASSICURANTE

UTILIZZA LA PAZIENZA E LA COMPrensIONE

FAI ATTENZIONE ALLE DISABILITA' FISICHE

COINVOLGI SE E' UTILE, I FAMILIARI O GLI AMICI

**RICORDA CHE NON SEI AUTORIZZATO
AD USARE LA FORZA FISICA**

**In caso di eccessiva AGGRESSIVITA' o RIFIUTO al
TRASPORTO : mettili in sicurezza.
Contatta il Servizio di Emergenza Sanitaria**

WAREL 118 Emergenza 112

TS



con il paziente affetto da dipendenza da alcool/droghe:

CERCA SEMPRE DI APRIRE UN CANALE COMUNICATIVO

USA UN TONO DI VOCE CALMO E RASSICURANTE

NON SOTTOVALUTARE I SEGNI CLINICI

In caso di eccessiva AGGRESSIVITA' o RIFIUTO al TRASPORTO : mettili in sicurezza, Contatta il Servizio di Emergenza Sanitaria







TS



con il paziente diversamente abile:

VALUTA IL TIPO DI HANDICAP E IL GRADO DI AUTONOMIA

RISPETTA I SUOI TEMPI

PERMETTI DI PORTARE GLI AUSILI INDISPENSABILI PER LE SUE RELAZIONI SOCIALI







TS



con lo straniero:

RISPETTA LA SUA CULTURA, LE SUE REGOLE E LA SUA RELIGIONE ANCHE QUANDO SONO MOLTO DIVERSE DALLE TUE

PARLA LENTAMENTE E CHIARAMENTE

SE HAI DIFFICOLTA' A COMUNICARE UTILIZZA I GESTI







TS

con il soggetto in regime di
"Custodia Cautelare"



LA RELAZIONE CON QUESTA CATEGORIA DI PAZIENTI NON DIFFERISCE NELLE MODALITA' APPRESE (RISPETTO, EMPATIA, ECC)

I PAZIENTI AGLI ARRESTI DOMICILIARI SONO TENUTI AD AVVISARE PERSONALMENTE LE FORZE DI POLIZIA.

IN CASO DI URGENZA (ES. PAZIENTE INCOSCIENTE) ATTIVA IL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA e RIFERITE DELLA SPECIFICA CONDIZIONE DI CUSTODIA CAUTELARE DEL PAZIENTE





TS







TS

Conclusioni



LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE CON IL PAZIENTE SONO PARTI INTEGRANTI DELL' ASSISTENZA ALLA PERSONA TRASPORTATA







TS

ANPAS

OBIETTIVI

- DEFINIRE IL COMPORTAMENTO E LE SUE DEVIANZE
- CONOSCERE I MOTIVI CHE PORTANO AD UN COMPORTAMENTO ANORMALE
- CONOSCERE LE PRINCIPALI MALATTIE MENTALI E LE PATOLOGIE ORGANICHE CHE POSSONO CAUSARE ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO
- SAPER APPROCCIARE UN SOGGETTO CON TURBE DEL COMPORTAMENTO GARANTENDO AUTOPROTEZIONE

WAREL 118 Emergenza 112

TS

ANPAS

IL COMPORTAMENTO

IL COMPORTAMENTO È L'INSIEME DELLE MANIFESTAZIONI ESTERIORI E DIRETTAMENTE OSSERVABILI CON LE QUALI UN INDIVIDUO RISPONDE ED INTERAGISCE CON L'AMBIENTE

```

graph TD
    EMOZIONI --> PENSIERI
    PENSIERI --> COMPORTAMENTO
    COMPORTAMENTO --> EMOZIONI
  
```

WAREL 118 Emergenza 112

TS

Perché esistono i disturbi del comportamento?

- ESPERIENZE INFANTILI PRECOCI, CON IMPULSI INCONSCI CHE TENDONO A RIEMERGERE
- IMPORTANZA DEL CONTESTO SOCIALE IN CUI L'UOMO È INSERITO

CONSEGUENZA DI PROBLEMI ORGANICI

TS

CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE MENTALI

PSICOSI: DISTURBI PSICHICI CHE INTERROMPONO IN MODO PIÙ O MENO GRAVE IL RAPPORTO DEL SOGGETTO CON LA REALTÀ E CON LA CONTINUITÀ DELLA SUA ESISTENZA

NEVROSI: STATI DI SOFFERENZA PSICHICA LEGATI A SITUAZIONI CONFLITTUALI SENZA COMPROMISSIONE DELLA CAPACITÀ DI ADERIRE ALLA REALTÀ

STATI DEFICITARI: CONDIZIONI DI DEFICIT INTELLETTIVO CONGENITO OD ACQUISITO NELLE QUALI È EVIDENZIABILE UNA CAUSA ORGANICA ED UNA CORRISPONDENTE ALTERAZIONE ANATOMOPATOLOGICA

TS

DISTURBI D'ANSIA

CHIUNQUE PRIMA DI SOSTENERE UNA PROVA, AVVERTE QUELLA SPIACEVOLE SENSAZIONE COMUNEMENTE CHIAMATA **ANSIA**, CHE RIENTRA IN UN REGIME DI NORMALITÀ.

QUANDO QUESTA SENSAZIONE DIVENTA STRESSANTE E PERSISTENTE, TANTO DA **IMPEDIRE AL SOGGETTO DI COMPORTARSI NEL MODO CONSUETO**, SI PARLA DI VERO E PROPRIO DISTURBO ANSIOSO

ATTACCO DI PANICO

**EPISODI ACUTI E TERRIFICANTI DI ANSIÀ INTENSA,
ACCOMPAGNATI DA SENSAZIONI DI PERDITA DEL
CONTROLLO E CATASTROFE INCOMBENTE**

SINTOMI:

DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA E SENSO DI SOFFOCAMENTO, LIPOTIMIE, PALPITAZIONE, TREMORI E BRIVIDI, ECCESSIVA SUDORAZIONE, NAUSEA, VOMITO, DIARREA, FORMICOLIO DEGLI ARTI, VAMPATE DI CALORE O SENSAZIONE DI FREDDO, DOLORE TORACICO, PAURA DI MORIRE E DI PERDERE IL CONTROLLO



NEVROSI (CRISI) ISTERICA

PRESENZA DI SINTOMI SOMATICI O PSICHICI CHE POSSONO "IMITARE" QUALSIASI QUADRO MORBOSO TENDENDO AD INTERESSARE UNA O PIU' PARTI DEL CORPO O L'INDIVIDUO NELLA SUA GLOBALITA' FINO A PROVOCARE GRAVI ALTERAZIONI DELLA COSCIENZA

SINTOMI:

CRISI MINORI: SIMULAZIONE DI CRISI EPILETTICA, EPISODI LIPOTIMICI O SINCOPIALI, PARALISI, AFONIA, ANESTESIE E FORMICOLII DIFFUSI, DISTURBI DEGLI ORGANI DI SENSO (CECITA' IMPROVVISA), AMNESIE

CRISI MAGGIORI: CRISI CONVULSIVA SEGUITA DA CONTORSIONI ACCOMPAGNATE DA GRIDA E UNA FASE DI TRANCE (VENGONO MIMATE SCENE DI VIOLENZA O EROTICHE)



DEPRESSIONE

**DIMINUIZIONE DEL LIVELLO AFFETTIVO DEL SOGGETTO
CON PROFONDA TRISTEZZA, PERDITA DI AUTOSTIMA,
DI FIDUCIA, DI MOTIVAZIONE ED IMPOVERIMENTO
DELLA SPINTA VITALE**

SINTOMI:

**PROFONDA E INSPIEGABILE TRISTEZZA,
DIMINUIZIONE DELLE FACOLTA' INTELLETTUALI,
RALLENTAMENTO MOTORIO, PERDITA
DELL' APPETITO, DISTURBI DEL SONNO, DIMINUIZIONE
DELLA MEMORIA, TENTATIVI DI SUICIDIO**



TS

LA DEMENZA

DEFICIT INTELLETTIVO INTERVENUTO IN SOGGETTI CON SVILUPPO PSICHICO RAGGIUNTO.

IL DANNO È PROGRESSIVO ED IRREVERSIBILE E GENERA GRAVI ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO E DELLA PERSONALITÀ

WAREL

118

Emergenza

112

TS

DEMENTIA SENILE

FISIOLOGICO DECADIMENTO PSICOFISICO DELL'ANZIANO

SONO PRESENTI:

- TURBE DELLA MEMORIA
- RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI INTELLETTIVE
- ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO
- INSONNIA
- ALTERAZIONI DEL LINGUAGGIO
- INCAPACITÀ DI RAGIONAMENTO E DI FORMULARE GIUDIZI
- SOGGETTO CONFABULANTE
- COMPARSA DI DELIRIO

WAREL

118

Emergenza

112

TS

MORBO DI ALZHEIMER

- DISTURBI A CARICO DELLA MEMORIA E DELL'ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
- SUCCESSIVA COMPARSA DI AFASIA AGNOSIA (MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI OGGETTI)
- AGITAZIONE PSICOMOTORIA CON ESPLOSIONI COLLERICHE IMPROVVISE
- IPERATTIVITÀ INCONCLUDENTE O AFINALISTICA

WAREL

118

Emergenza

112

TS

PATOLOGIE ORGANICHE
 CHE POSSONO MODIFICARE IL
 COMPORTAMENTO

- TRAUMA CRANICO
- IPOGLICEMIA
- MALATTIE INFETTIVE/IPERtermia
- ALTERAZIONI METABOLICHE
- ABUSO DI ALCOOL
- ABUSO DI SOSTANZE PSICOATTIVE
- IPOSSIA

TS

IPOSSIA

PRINCIPALI CAUSE:

PATOLOGIE RESPIRATORIE, TRAUMA CRANICO, IPOVOLEMIA, INTOSSICAZIONE DA FUMO, CRISI EPILETTICHE, ICTUS, ASSUNZIONE INCONGRUA DI FARMACI

- SPESSO L'AGITAZIONE PSICOMOTORIA È IL PRIMO SEGNALE DI RIDOTTO APPORTO DI OSSIGENO AL CERVELLO
- LO STATO DI COMA PUÒ ESSERE L'EVOLUZIONE SUCCESSIVA

TS

ABUSO DI ALCOOL

- SINTOMI E SEGNALE
 - ODORE TIPICO DELL'ALITO E SUGLI INDUMENTI
 - MOVIMENTO ONDEGGIANTE E INCERTO
 - INCAPACITÀ A CONDURRE UNA NORMALE CONVERSAZIONE
 - VOLTO ARROSSATO SENSAZIONE DI CALORE E IPERSUDORAZIONE
 - NAUSEA E VOMITO
 - N.B. ATTENZIONE AL VOMITO!! IL SOGGETTO POTREBBE NON ESSERE IN GRADO DI PROTEGGERE AUTONOMAMENTE LE VIE AEREE

TS

SEGNALI DI ASTINENZA DA ALCOL (DELIRIUM TREMENS)

- STATO CONFUSIONALE
- IRREQUIETEZZA
- ALLUCINAZIONI
- TREMORE DELLE MANI
- IPERSUDORAZIONE
- COMPORTAMENTO ATIPICO
- CONVULSIONI



WAREL

118

Emergenza

112

TS

ABUSO DI SOSTANZE PSICOATTIVE

LA SINTOMATOLOGIA LEGATA ALL'ABUSO DI SOSTANZE PSICOATTIVE È SPESSO SIMILE A QUELLA DELLE URGENZE MEDICHE, PERTANTO IL SOGGETTO DEVE ESSERE TRATTATO COME OGNI ALTRA URGENZA MEDICA

IN QUALITÀ DI SOCCORRITORI NON DOVRESTE MAI SOTTOVALUTARE L'ABUSO DI DROGHE

I SINTOMI SONO SEMPRE SOGGETTIVI E RESI PIÙ DIFFICILI DAL FATTO CHE SPESSO VENGONO ASSUNTE PIÙ DROGHE E SOSTANZE CHIMICHE CONTEMPORANEAMENTE



WAREL

118

Emergenza

112

TS

LA GESTIONE DEL COMPORTAMENTO "NON PREVEDIBILE"

MANTENETE SEMPRE UN COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

MANTENETE LA CALMA, NON REAGIRE AD INSULTI, EVITARE RISPOSTE ECCESSIVE A PAROLE O GESTI DEL SOGGETTO

PARLATE CON IL SOGGETTO E ASCOLTATE CIÒ CHE VI DICE, FATEGLI CAPIRE CHE INTENDETE AIUTARLO E CHE AVETE COMPRESO IL SUO PROBLEMA

EVITATE CONVERSAZIONI INADEGUATE, NON DATE SOLUZIONI SUPERFICIALI AL PROBLEMA, NON DITEGLI CHE VA TUTTO BENE SE NON È VERO

WAREL

118

Emergenza

112

TS

LA GESTIONE DEL COMPORTAMENTO

"NON PREVEDIBILE"

LASCIATE LA GESTIONE DEL PAZIENTE A CHI E' IN GRADO DI FARLO E SE LA SENTE, NON NECESSARIMENTE IL CAPO EQUIPAGGIO (ALTRI COMPONENTI DELL'EQUIPAGGIO, FORZE DI POLIZIA, PARENTE, ECC.)

VALUTATE IL SOGGETTO SECONDO LE PRIORITÀ, EVITANDO IL PREGIUDIZIO

VALUTATE SEGNI E SINTOMI IPOTIZZANDO SEMPRE UN' URGENZA MEDICA (per es. un malore) e SOLO SUCCESSIVAMENTE PENSARE AD UNA PATOLOGIA PSICHIATRICA O ABUSO DI SOSTANZE

NON ASSUMETE UN ATTEGGIAMENTO DI SFIDA

WAREU

118

Emergenza

112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TS

AUTOPROTEZIONE

ANCHE I SOGGETTI CHE SEMBRANO ESSERE INIZIALMENTE CALMI, POSSONO ASSUMERE ATTEGGIAMENTI VIOLENTI

SE IL SOGGETTO CREA UNA CONDIZIONE PERICOLOSA PER VOI, PROTEGGETEVI ALLONTANANDOVIS IN UN LUOGO SICURO, SENZA PERDERE DI VISTA IL PAZIENTE, CHIEDETE AL SISTEMA D'EMERGENZA L'INTERVENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

WAREU

118

Emergenza

112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TS

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Conclusioni



ABBIAMO DEFINITO IL COMPORTAMENTO E LE SUE
DEVIANZE RICONOSCENDO I MOTIVI CHE PORTANO
AD UN COMPORTAMENTO ANORMALE

ABBIAMO PRESENTATO LE PRINCIPALI MALATTIE MENTALI E
LE PATOLOGIE ORGANICHE CHE POSSONO CAUSARE
ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO E L'APPROCCIO AD
UN SOGGETTO CON TURBE DEL COMPORTAMENTO
GARANTENDO AUTOPROTEZIONE
